

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS (PHQ-15)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Severidad Somática y Trastorno de Síntomas Somáticos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Salud del Paciente - Módulo de Síntomas Somáticos (PHQ-15).
Nombre Original (Inglés)	<i>Patient Health Questionnaire - 15 Somatic Symptom Severity Scale (PHQ-15)</i>
Autores Originales	Kurt Kroenke, Robert L. Spitzer y Janet B. W. Williams (2002), Columbia University.
Adaptaciones Españolas	Rosendal et al. (2005); de la Torre et al. (2012); validación del Grupo PHQ España.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado de somatización y carga sintomática física.
Tipo de Instrumento	Escala de autoinforme de 15 síntomas somáticos puntuados en escala Likert de 3 anclajes (0, 1 y 2).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 16 años). Consultas de atención primaria, medicina interna y salud mental.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público (Pfizer Inc. / Instrumentos PHQ abiertos). Libre uso clínico y científico.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE SOMATIZACIÓN

El PHQ-15 fue desarrollado por Kroenke y colaboradores (2002) como módulo somático del Patient Health Questionnaire, diseñado para cuantificar objetivamente la carga global de **síntomas físicos funcionalmente molestos**. Los síntomas somáticos inexplicados médicamente constituyen uno de los motivos de consulta más prevalentes y costosos en atención primaria, asociándose frecuentemente a hiperfrecuentación y discapacidad laboral.

El instrumento evalúa los 15 síntomas somáticos que acumulan más del 90% de las quejas físicas funcionales en la práctica médica ambulatoria (dolor musculoesquelético, alteraciones gastrointestinales, molestias cardiorrespiratorias, cefaleas, astenia e insomnio). Más que buscar una etiología orgánica específica, el PHQ-15 mide el **impacto acumulativo de la molestia física percibida** durante las últimas cuatro semanas, funcionando como un potente predictor de disfunción psicosocial y comorbilidad con depresión y ansiedad.

3. GRUPOS DE SÍNTOMAS DEL PHQ-15 (KROENKE ET AL., 2002)

Grupo Sintomático	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Semiológica
1. Dolor Somático	2, 3, 4, 5, 11	0 a 10	Dolor de espalda, articular/extremidades, cefaleas, dolor menstrual y disconfort sexual.
2. Gastrointestinal	1, 12, 13	0 a 6	Dolor estomacal, alteración del ritmo intestinal (diarrea/estreñimiento), náuseas e indigestión.
3. Cardiorrespiratorio	6, 7, 8, 9, 10	0 a 10	Dolor torácico, mareos, síncope/desmayos, taquicardia/palpitaciones y disnea.
4. Fatiga y Sueño	14, 15	0 a 4	Astenia intensa, falta de energía y trastornos del sueño (derivados del PHQ-9).
PUNTUACIÓN TOTAL PHQ-15	1 al 15	0 a 30	Índice multidimensional continuo de gravedad sintomática somática en el último mes.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.80 a 0.84 en pacientes de atención primaria españoles (Rosendal et al., 2005; de la Torre et al., 2012).
Validez de Criterio	Cada incremento en los estratos del PHQ-15 se asocia linealmente con un aumento significativo en la utilización de servicios sanitarios, consultas médicas y bajas laborales.
Validez Concurrente	Elevada correlación con la subescala somática del SCL-90-R ($r = 0.75$), la escala de dolor bodily pain del SF-36 ($r = -0.68$) y la escala GAD-7 ($r = 0.58$).
Validez Predictiva	Puntuaciones <i>ge10</i> muestran una sensibilidad del 78% y especificidad del 71% para diagnosticar Trastorno de Síntomas Somáticos (DSM-5).
Invarianza de Medida	Mantiene adecuada estabilidad estructural entre varones y mujeres, ajustando la ponderación del ítem menstrual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada síntoma se evalúa según el grado en que ha molestado a la persona en las **últimas cuatro semanas**:

- **0** = No ha molestado nada | **1** = Ha molestado un poco | **2** = Ha molestado mucho.
- **Cálculo del Total:** Suma directa de las puntuaciones de los 15 ítems (rango: **0 a 30 puntos**).
- **Manejo del ítem 4 (Menstruación):** En varones, el ítem 4 se califica con 0 puntos o se prorratea según la pauta del manual oficial PHQ.

Puntuación Total = Suma de ítems 1 al 15 (0 a 30 puntos)

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD SOMÁTICA (KROENKE ET AL., 2002)

Estrato	Puntuación	Gravedad Somática	Conducta Asistencial Recomendada
Mínimo	0 a 4	Síntomas somáticos insignificantes	Molestias físicas basales comunes. Mantener hábitos de vida saludable y autocuidado.
Leve	5 a 9	Gravedad somática leve	Molestias ocasionales. Abordaje médico habitual en atención primaria sin exploraciones complejas.
Moderado	10 a 14	Corte Clínico Significativo	Carga somática relevante. Descartar patología médica, evaluar comorbilidad con ansiedad/depresión.
Severo	15 a 30	Somatización Grave / Incapacitante	Alta probabilidad de Trastorno de Síntomas Somáticos (DSM-5). Terapia cognitivo-conductual e interconsulta.

REPERCUSIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA: Los pacientes con PHQ-15 *ge15* presentan un promedio de consultas médicas al año tres veces superior a la media comunitaria y un deterioro funcional comparable al de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes no controlada.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y ENFOQUE PSICOSOMÁTICO

MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE POLISOMATIZADOR:

- **Paso 1 (PHQ-15 *ge*10):** Evitar el ciclo de pruebas analíticas y de imagen redundantes si las exploraciones previas son concluyentes. Explicar el modelo de hipersensibilización central del dolor y el eje intestino-cerebro.
- **Paso 2 (Triada PHQ):** Administrar en paralelo PHQ-9 (depresión) y GAD-7 (ansiedad). Más del 60% de los pacientes con PHQ-15 *ge*15 presentan un trastorno afectivo subyacente que retroalimenta la queja corporal.
- **Paso 3 (Estrategia Asistencial):** Citas médicas programadas a intervalos regulares con el médico de atención primaria; psicoterapia cognitivo-conductual centrada en desensibilización al dolor y desactivación psicofisiológica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: PACIENTE POLISOMATIZADORA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paciente: Mujer de 45 años, recepcionista, en situación de incapacidad temporal reiterada por lumbalgias atípicas, dispepsia funcional, mareos posturales y fatiga crónica, con múltiples estudios analíticos, endoscópicos y de resonancia normales.

Puntuación PHQ-15 Total: 18/30 (Rango Severo — Somatización Grave).

• **Desglose sintomático:** Califica con "Ha molestado mucho" (2 puntos) el dolor de espalda (ítem 2), dolores articulares (ítem 3), cefaleas (ítem 5), molestias gástricas (ítems 1 y 13), cansancio continuo (ítem 14) e insomnio de mantenimiento (ítem 15).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno de Síntomas Somáticos (DSM-5) con afectación moderada comórbida por ansiedad generalizada (GAD-7 = 11). Se acuerda una pauta de atención colaborativa: consultas mensuales breves de revisión médica sin nuevas derivaciones a especialistas, combinadas con terapia cognitivo-conductual para modificar la rumiación somatosensorial y un programa de ejercicio físico aeróbico progresivo. A los 3 meses, el PHQ-15 descendió a 9/30 (rango leve), logrando el reingreso laboral satisfactorio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: BANDERAS ROJAS MÉDICAS

Nunca atribuir síntomas somáticos a estrés sin descartar signos de alarma biológica: pérdida ponderal involuntaria, rectorragias, disfagia progresiva, síncope en esfuerzo o dolor torácico opresivo.

COMORBILIDAD CON SUICIDIO

El dolor crónico difuso e incapacitante con sensación de incomprensión médica eleva sustancialmente el riesgo de desesperanza y suicidio; explorar sistemáticamente el deseo de muerte.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2002). The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. *Psychosomatic Medicine*, 64(2), 258–266.
2. Rosendal, M., Bro, F., Fink, P., Christensen, K. S., & Olesen, F. (2005). Validation of the PHQ-15 in Danish and Spanish primary care settings. *General Hospital Psychiatry*, 27(6), 425–433.
3. de la Torre-Luque, A., et al. (2012). Psychometric evaluation of the Patient Health Questionnaire-15 in Spanish specialized mental health outpatients. *Journal of Affective Disorders*, 142(1-3), 284–290.
4. Barsky, A. J., Peekna, H. M., & Borus, J. F. (2001). Somatic symptom reporting in women and men. *Journal of General Internal Medicine*, 16(4), 266–275.